

GEBELİKTE HİPERTANSİYF HASTALIKLAR

BÖLÜM I — TUS TARZI VAKA SORULARI

1. 32 yaşında, 28 haftalık gebede daha önce hipertansiyon öyküsü yoktur. İki ayrı ölçümde kan basıncı 148/94 mmHg ve 150/96 mmHg saptanıyor. Proteinüri yoktur; trombosit sayısı, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri normaldir.

Bu hasta için en olası tanı hangisidir?

- A) Kronik hipertansiyon
- B) Preeklampsi
- C) Gestasyonel hipertansiyon
- D) Süperempoze preeklampsi
- E) Eklampsi

2. 10 haftalık gebenin ilk antenatal vizitinde kan basıncı 150/95 mmHg bulunuyor. Daha önce hipertansiyon tanısı almamıştır.

Bu hasta için en olası tanı hangisidir?

- A) Gestasyonel hipertansiyon
- B) Preeklampsi
- C) Kronik hipertansiyon
- D) Eklampsi
- E) HELLP sendromu

3. 31 haftalık gebede kan basıncı 165/110 mmHg ölçülüyor. İdrarda proteinüri negatiftir. Trombosit sayısı 92.000/ μ L, serum kreatinin 1,3 mg/dL bulunuyor.

Bu hasta için en doğru tanı hangisidir?

- A) Gestasyonel hipertansiyon
- B) Kronik hipertansiyon
- C) Preeklampsi
- D) Eklampsi
- E) HELLP sendromu

4. Aşağıdakilerden hangisi preeklampsinin şiddetli özelliklerinden biri değildir?

- A) Kan basıncının 162/112 mmHg olması
- B) Trombosit sayısının 90.000/ μ L olması
- C) Pulmoner ödem
- D) Persistan görme bozukluğu
- E) 24 saatlik idrarda 350 mg proteinüri

5. 34 haftalık gebede kan basıncı 172/114 mmHg ölçülüyor; 20 dakika sonra tekrarlanan ölçümde 170/112 mmHg bulunuyor.

Bu hastada en uygun yaklaşım hangisidir?

- A) 24 saatlik idrar proteini sonucunu beklemek
- B) Metildopa başlamak
- C) Akut antihipertansif tedaviyi başlamak
- D) Yalnızca fetal NST yapmak
- E) 24 saat sonra kan basıncını tekrar ölçmek

6. **Gebelikte akut ciddi hipertansiyonun tedavisinde aşağıdakilerden hangisi standart ilk basamak seçeneklerden biri değildir?**

- A) IV labetalol
- B) IV hidralazin
- C) Oral immediate-release nifedipin
- D) Oral metildopa
- E) IV labetalole yanıt alınamazsa IV hidralazine geçilmesi

7. 35 haftalık preeklampsia tanılı gebede jeneralize tonik-klonik nöbet geliyor.

Bu hastada ilk tercih edilmesi gereken antikonvülzan ilaç hangisidir?

- A) Diazepam
- B) Fenitoin
- C) Magnezyum sülfat
- D) Valproat
- E) Midazolam

8. Eklampsia nedeniyle magnezyum sülfat infüzyonu alan hastada patellar refleksler kayboluyor ve solunum sayısı 8/dk'ya düşüyor.

Bu hastada en uygun yaklaşım hangisidir?

- A) Magnezyum sülfat dozunu artırmak
- B) Kalsiyum glukonat vermek
- C) Diazepam vermek
- D) Labetalol vermek
- E) Furosemid vermek

9. 33 haftalık gebe epigastrik ağrı ile başvuruyor.

- Kan basıncı: 165/105 mmHg
- AST ve ALT: yüksek
- Trombosit: 68.000/ μ L
- LDH: belirgin yüksek

Bu hasta için en olası tanı hangisidir?

- A) Akut yağlı karaciğer
- B) HELLP sendromu
- C) TTP
- D) Hemolitik üremik sendrom
- E) Gestasyonel hipertansiyon

10. HELLP sendromunda hemolizi destekleyen laboratuvar bulgusu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) LDH düzeyinin düşük olması
- B) İndirekt bilirubin artışı
- C) Haptoglobulin artışı
- D) Retikülositopeni
- E) Direkt bilirubin artışı

11. Kronik hipertansiyonu olan ve daha önce proteinürisi saptanmamış 30 haftalık gebede yeni başlayan 2+ proteinüri ve trombositopeni gelişiyor.

Bu hasta için en olası tanı hangisidir?

- A) Gestasyonel hipertansiyon
- B) Kronik hipertansiyon
- C) Süperempoze preeklampsi
- D) Eklampsi
- E) HELLP sendromu

12. Preeklampside uteroplental perfüzyon bozukluğunun en karakteristik fetal sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

- A) Makrozomi
- B) Fetal büyüme kısıtlılığı
- C) Polihidramnios
- D) Postmatürite
- E) Fetal hipertiroidi

13. Önceki gebeliğinde 30. haftada ağır preeklampsi nedeniyle doğum yapmış olan kadın şu an 10 haftalık gebedir.

Bu hasta için aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi uygundur?

- A) Gebelik boyunca magnezyum sülfat verilmesi
- B) 12. haftadan itibaren düşük doz aspirin başlanması
- C) 20. haftadan itibaren ACE inhibitörü başlanması
- D) Rutin diüretik kullanımı
- E) Tuz kısıtlaması

14. Düşük doz aspirin profilaksisi aşağıdaki durumların hangisinde rutin olarak önerilmez?

- A) Önceki preeklampsi öyküsü
- B) Kronik hipertansiyon
- C) Çoğul gebelik
- D) Tip 1 diyabet
- E) Preeklampsi risk faktörü olmayan gebede yalnızca fetal büyüme kısıtlılığını önleme amacı

15. Eklampsi ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

- A) Antepartum dönemde gelişebilir.
- B) İntrapartum dönemde gelişebilir.
- C) Postpartum dönemde gelişebilir.
- D) Yalnızca doğumdan önce gelişir.
- E) Tedavide temel ilaç magnezyum sülfattır.

16. Aşağıdaki antihipertansif ilaçlardan hangisi gebelikte kontrendikedir?

- A) Labetalol
- B) Nifedipin
- C) Metildopa
- D) Enalapril
- E) Hidralazin

17. 37 haftalık gebede preeklampsi tanısı mevcuttur. Maternal ve fetal durum stabildir.

Bu hastada en uygun yaklaşım hangisidir?

- A) 40. haftaya kadar beklemek
- B) Gebeliği süresiz sürdürmek
- C) Doğumu planlamak
- D) Magnezyum sülfat altında 39. haftaya kadar beklemek
- E) ACE inhibitörü başlamak

18. 29 haftalık preeklampsi tanılı gebede kan basıncı tedaviye rağmen kontrol altına alınamıyor ve pulmoner ödem geliyor.

Bu hastada en doğru yaklaşım hangisidir?

- A) Gebeliği rutin olarak 37. haftaya kadar sürdürmek
- B) Yalnızca aspirin başlamak
- C) Maternal stabilizasyon sonrası doğumu gerçekleştirmek
- D) ACE inhibitörü başlamak
- E) Yalnızca fetal büyümeyi takip etmek

19. Aşağıdakilerden hangisi preeklampsi için yüksek risk faktörlerinden biridir?

- A) Tek başına nulliparite
- B) 35 yaşında olmak
- C) Kronik hipertansiyon
- D) İki gebelik arasındaki sürenin 3 yıl olması
- E) Hafif demir eksikliği

20. 34 haftalık gebe şiddetli frontal baş ağrısı ve görme bulanıklığı ile başvuruyor.

- Kan basıncı: 170/112 mmHg
- Trombosit: 78.000/ μ L
- AST: 180 U/L
- Kreatinin: 1,4 mg/dL
- Proteinüri: 1+

Bu hasta için en doğru yaklaşım hangisidir?

- A)** Gestasyonel hipertansiyon kabul edilip izlenmesi
- B)** Proteinüri miktarı düşük olduğu için preeklampsinin dışlanması
- C)** Ciddi özellikli preeklampsi düşünülerek maternal stabilizasyon, $MgSO_4$ ve uygun antihipertansif tedavinin planlanması
- D)** Yalnızca aspirin başlanması
- E)** 37. haftaya kadar beklenmesi

BÖLÜM II — ZOR VAKALAR

1. 32 yaşında, G2P1 kadın 31. gebelik haftasında baş ağrısı ve görmede bulanıklık yakınmasıyla başvuruyor.

- Kan basıncı: 148/94 mmHg
- 24 saatlik idrarda protein: 280 mg/gün
- Trombosit: 82.000/ μ L
- AST: normal
- Kreatinin: 0,9 mg/dL

Bu hasta için en doğru tanı hangisidir?

- A) Gestasyonel hipertansiyon
- B) Kronik hipertansiyon
- C) Proteinürisiz preeklampsi
- D) Ciddi özellikli preeklampsi
- E) Kronik hipertansiyon üzerine süperempoze preeklampsi

2. 35 haftalık gebede kan basıncı 168/112 mmHg ölçülüyor; 15 dakika sonra tekrarlanan ölçümde 166/110 mmHg bulunuyor. Hasta asemptomatiktir. İdrar stick testinde proteinüri (+) saptanıyor.

Bu hastada ilk yapılması gereken yaklaşım hangisidir?

- A) 24 saatlik idrar proteinini tamamlamak
- B) Betametazon uygulayıp 24 saat beklemek
- C) Antihipertansif tedaviyi acilen başlamak
- D) Magnezyum sülfat başlayıp doğumu gerçekleştirmek
- E) Doppler USG sonucunu beklemek

3. 39 haftalık preeklampsi tanılı kadın doğum sırasında jeneralize tonik-klonik nöbet geçiriyor ve $MgSO_4$ başlanıyor. Bir süre sonra aşağıdaki bulgular geliyor:

- Patellar refleksler kayboluyor
- Solunum sayısı 9/dk
- İdrar çıkışı belirgin azalmış

Bu hastada en uygun yaklaşım hangisidir?

- A) Diazepam
- B) Fenitoin
- C) Kalsiyum glukonat
- D) Labetalol
- E) Furosemid

4. 34 haftalık gebe bulantı, sağ üst kadranda ağrısı ve halsizlik yakınmalarıyla başvuruyor. Laboratuvar bulguları şöyledir:

- Hemoglobin: 8,9 g/dL
- LDH: 920 U/L
- AST: 180 U/L
- ALT: 150 U/L
- Trombosit: 72.000/ μ L
- Bilirubin: yüksek
- Kreatinin: 1,3 mg/dL
- Glukoz: normal

Bu hasta için en olası tanı hangisidir?

- A) Akut yağlı karaciğer
- B) HELLP sendromu
- C) TTP
- D) Gebeliğin intrahepatik kolestazı
- E) Hemolitik üremik sendrom

5. Daha önce kronik hipertansiyon tanısı almış 10 haftalık gebe antihipertansif ilaç kullanmıyor. Tekrarlayan ölçümlerde kan basıncı 146/92 mmHg bulunuyor. Proteinüri yoktur, laboratuvar tetkikleri normaldir.

Güncel kanıtlar doğrultusunda bu hastanın yönetimiyle ilgili aşağıdakilerden hangisi en uygundur?

- A) Tedaviye ancak kan basıncı 160/110 mmHg olduğunda başlanmalıdır.
- B) Antihipertansif tedavi gebelik boyunca kontrendikedir.
- C) Antihipertansif tedavi düşünülmeli ve hedef kan basıncı <140/90 mmHg olacak şekilde yönetilmelidir.
- D) Magnezyum sülfat başlanmalıdır.
- E) Aspirin başlanması antihipertansif tedavinin yerine geçer.

6. Kronik hipertansiyonu olan 28 haftalık gebenin bulguları şöyledir:

- Başlangıç proteinürisi: 150 mg/24 saat
- Şimdiki proteinüri: 1,2 g/24 saat
- Kan basıncı: 152/96 mmHg
- Trombosit: 95.000/ μ L
- AST: 110 U/L

Bu hasta için en uygun tanı hangisidir?

- A) Gestasyonel hipertansiyon
- B) Kronik hipertansiyon
- C) Süperempoze preeklampsi
- D) HELLP sendromu
- E) Kronik böbrek hastalığına bağlı proteinüri

7. Preeklampsi açısından yüksek riskli 13 haftalık gebeye koruyucu tedavi olarak düşük doz aspirin planlanıyor.

Aspirin kullanımıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi güncel önerilere en uygundur?

- A) 20. haftadan sonra başlanmalıdır.
- B) 12-28. haftalar arasında başlanabilir; ideal olarak 16. haftadan önce başlanması tercih edilir.
- C) Yalnızca proteinüri başladıktan sonra verilmelidir.
- D) Yalnızca hipertansiyon geliştiğinde başlanmalıdır.
- E) Doğuma kadar değil, 28. haftada kesilmelidir.

8. 36+4 haftalık preeklampsi tanılı gebenin bulguları şöyledir:

- Kan basıncı: 148/94 mmHg
- Trombosit: 145.000/ μ L
- AST: normal
- Kreatinin: normal
- Fetal büyüme: normal
- CTG: normal
- Semptom yok

NICE önerilerine göre bu hastada aşağıdaki yaklaşımlardan hangisi en doğrudur?

- A) 34. haftada doğum yapılmalıydı.
- B) 37. haftaya kadar her koşulda beklenmelidir.
- C) 37. haftadan itibaren doğumun başlatılması önerilir.
- D) Yalnızca proteinüri 5 g/gün üzerine çıkarsa doğum yapılır.
- E) Sezaryen ile doğum zorunludur.

9. 30 haftalık gebenin ultrasonografisinde fetal hidrops, plasentomegali ve polihidramnios saptanıyor. Annenin muayene ve tetkiklerinde ise aşağıdaki bulgular vardır:

- Yaygın ödem
- Kan basıncı: 150/95 mmHg
- Proteinüri: (+)
- Hafif anemi

Bu tabloda özellikle hangi tanı düşünülmelidir?

- A) HELLP sendromu
- B) Mirror sendromu
- C) Akut yağlı karaciğer
- D) Kronik hipertansiyon
- E) TTP

10. 32 haftalık gebenin bulguları şöyledir:

- Kan basıncı: 135/85 mmHg
- Trombosit: 28.000/ μ L
- Hemoglobin: 7,6 g/dL
- LDH: çok yüksek
- Periferik yaymada şistosit: (+)
- AST: 65 U/L
- ALT: 55 U/L
- Kreatinin: 2,4 mg/dL
- Belirgin proteinüri yok
- Nörolojik semptomlar mevcut

Bu hasta için en olası tanı hangisidir?

- A)** HELLP sendromu
- B)** Preeklampsia
- C)** TTP
- D)** Akut yağlı karaciğer
- E)** Gestasyonel trombositopeni

CEVAP ANAHTARI VE AÇIKLAMALAR

Bölüm I — TUS Tarzı Vaka Soruları

1 C	2 C	3 C	4 E	5 C	6 D	7 C	8 B	9 B	10 B
11 C	12 B	13 B	14 E	15 D	16 D	17 C	18 C	19 C	20 C

Soru 1 — Cevap: C) Gestasyonel hipertansiyon

≥20. haftada başlayan hipertansiyon + proteinüri veya maternal organ disfonksiyonu yok → **gestasyonel hipertansiyon**.

Soru 2 — Cevap: C) Kronik hipertansiyon

Gebeliğin **20. haftasından önce** saptanan hipertansiyon → **kronik hipertansiyon** kabul edilir.

Soru 3 — Cevap: C) Preeklampsi

Proteinüri şart değildir. Hipertansiyona maternal organ disfonksiyonu eşlik ediyorsa preeklampsi tanısı konabilir.

Soru 4 — Cevap: E) 24 saatlik idrarda 350 mg proteinüri

TUS tuzağı: Proteinüri miktarı hastalığın **“şiddetli özellik” kriteri değildir.**

Soru 5 — Cevap: C) Akut antihipertansif tedaviyi başlamak

Sistolik ≥160 veya diyastolik ≥110 mmHg **ciddi akut hipertansiyondur** ve gecikmeden tedavi edilmelidir. Akut tedavi seçenekleri: IV labetalol, IV hidralazin veya oral immediate-release nifedipin.

Soru 6 — Cevap: D) Oral metildopa

Metildopa kronik hipertansiyon tedavisinde kullanılabilir; akut hipertansif kriz ilacı değildir.

Soru 7 — Cevap: C) Magnezyum sülfat

Preeklampsi + nöbet = **eklampsi** → **MgSO₄**.

Soru 8 — Cevap: B) Kalsiyum glukonat vermek

Mg toksisitesi → **kalsiyum glukonat**.

Soru 9 — Cevap: B) HELLP sendromu

HELLP = Hemolysis + Elevated Liver enzymes + Low Platelets.

Soru 10 — Cevap: B) İndirekt bilirubin artışı

Hemolizde **LDH ↑, indirekt bilirubin ↑, haptoglobin ↓** beklenir.

Soru 11 — Cevap: C) Süperempoze preeklampsi

Kronik hipertansiyon + yeni preeklampitik bulgular → **süperempoze preeklampsi**.

Soru 12 — Cevap: B) Fetal büyüme kısıtlılığı

Preeklampsi → uteroplasental yetmezlik → **FGR**.

Soru 13 — Cevap: B) 12. haftadan itibaren düşük doz aspirin başlanması

ACOG/SMFM, yüksek riskli gebelerde **81 mg/gün** düşük doz aspirinin **12-28. haftalar** arasında, ideal olarak **16. haftadan önce** başlanmasını öneriyor. TUS şifresi: Önceki erken/ağır preeklampsi → aspirin profilaksisi.

Soru 14 — Cevap: E) Preeklampsi risk faktörü olmayan gebede yalnızca fetal büyüme kısıtlılığını önleme amacı

ACOG, preeklampsi risk faktörü bulunmaksızın **yalnızca** FGR, spontan preterm doğum veya gebelik kaybını önlemek amacıyla aspirin kullanılmasını desteklemiyor.

Soru 15 — Cevap: D) Yalnızca doğumdan önce gelişir.

TUS tuzağı: Eklampsi **postpartum** dönemde de görülebilir.

Soru 16 — Cevap: D) Enalapril

ACE inhibitörleri ve ARB'ler gebelikte kontrendikedir.

Soru 17 — Cevap: C) Doğumu planlamak

37 hafta ve üzeri preeklampside, maternal/fetal değerlendirme sonrasında doğum önerilir.

Soru 18 — Cevap: C) Maternal stabilizasyon sonrası doğumu gerçekleştirmek

Kontrol edilemeyen ciddi hipertansiyon + pulmoner ödem = gebeliğin devamı maternal açıdan kabul edilemez hale gelebilir.

Soru 19 — Cevap: C) Kronik hipertansiyon

ACOG'un yüksek risk faktörleri arasında önceki preeklampsi, çoğul gebelik, böbrek hastalığı, otoimmün hastalık, tip 1/tip 2 diyabet ve **kronik hipertansiyon** bulunur.

Soru 20 — Cevap: C) Ciddi özellikli preeklampsi düşünülerek maternal stabilizasyon, MgSO₄ ve uygun antihipertansif tedavinin planlanması

TUS'un istediği bütün zincir: ≥ 20 . hafta hipertansiyon → preeklampsi → ciddi özellikler → akut hipertansiyon tedavisi + MgSO₄ + maternal/fetal değerlendirme → uygun zamanda doğum.

Bölüm II — Zor Vakalar

1 D	2 C	3 C	4 B	5 C	6 C	7 B	8 C	9 B	10 C
------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------

Soru 1 — Cevap: D) Ciddi özellikli preeklampsi

Proteinüri olmadan da **preeklampsi + ciddi özellik** olabilir.

Soru 2 — Cevap: C) Antihipertansif tedaviyi acilen başlamak

$\geq 160/110$ mmHg → **acil antihipertansif tedavi**.

Soru 3 — Cevap: C) Kalsiyum glukonat

Mg toksisitesi → **kalsiyum glukonat**.

Soru 4 — Cevap: B) HELLP sendromu

Hemoliz + karaciğer enzimlerinde artış + düşük trombosit = **HELLP**.

Soru 5 — Cevap: C) Antihipertansif tedavi düşünülmeli ve hedef kan basıncı $<140/90$ mmHg olacak şekilde yönetilmelidir.

CHAP sonrası kronik hipertansiyonda $\geq 140/90$ mmHg **tedavi eşiği**. Bu soru özellikle eski TUS bilgisi ile güncel bilgiyi ayırır. CHAP çalışmasında 140/90 mmHg eşliğinde tedavi stratejisi, yalnızca ağır hipertansiyon gelişince tedaviye kıyasla daha iyi gebelik sonuçlarıyla ilişkiliydi ve SGA riskinde artış göstermedi. ACOG da CHAP sonuçlarını pratiğe entegre etti.

Soru 6 — Cevap: C) Süperempoze preeklampsi

Kronik hipertansiyon + yeni preeklampitik bulgular → **süperempoze preeklampsi**.

Soru 7 — Cevap: B) 12-28. haftalar arasında başlanabilir; ideal olarak 16. haftadan önce başlanması tercih edilir.

Aspirin: **12-28. haftalar** arasında; ideal olarak **16. haftadan önce**. NICE de yüksek riskli kadınlarda 12. haftadan doğuma kadar 75-150 mg/gün aspirin önermektedir.

Soru 8 — Cevap: C) 37. haftadan itibaren doğumun başlatılması önerilir.

NICE, preeklampside **37. haftadan itibaren 24-48 saat içinde** doğumun başlatılmasını önerir; daha erken haftalarda ise maternal-fetal durum ve erken doğum endikasyonları değerlendirilir.

Soru 9 — Cevap: B) Mirror sendromu

TUS ipucu: **Fetal hidrops + plasentomegali + maternal ödem/hipertansif tablo = Mirror sendromu.**

Soru 10 — Cevap: C) TTP

Çok ağır trombositopeni + MAHA + nörolojik/renal bulgular → **TTP**.